

신장암 진단 첫 30일

감시 · 부분절제 · 면역치료 결정

처음 진단받은 환자와 보호자를 위한 핵심 정리 · 질문 · 행동 가이드

ApuDa 「암 진단 첫 30일」 시리즈 06

완전판 · 2026년 10월 개정 2판

작은 신장 종양은 ‘모두 떼어내야 하는 암’과 같은 말이 아닙니다.

이 책을 펴기 전에

- 이 책은 **일반적인 환자교육 자료**입니다. 나의 병기, 치료 순서, 약 선택, 예후는 담당 의료진과 함께 결정합니다.
- 의학정보 확인일: **2026.10.04** · 참고 지침: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology — Kidney Cancer, Version 1.2027 외 국내 자료 (본문 끝 「근거와 한계」 참고)
- 약의 국내 허가·건강보험 급여 기준과 제도(산정특례·지원사업)는 자주 바뀝니다. 실제 적용 전 병원 원무과·국민건강보험공단(1577-1000)에서 다시 확인하세요.
- 이 책은 NCCN이 검토하거나 승인한 자료가 아니며, ApuDa가 독자적으로 쓴 환자교육 저작물입니다.

이 책의 사용법

이 책은 처음부터 끝까지 읽는 책이 아닙니다. **지금 내 상황에 필요한 장만 펴서 쓰는 책**입니다.

지금 내 상황	먼저 펼 곳
방금 진단을 들었고 머리가 하얗다	1장 「먼저 구분하세요」 → 「진단 뒤 72시간」
몸에 이상 신호가 있다	「기다리지 않는 신호」 (응급 상자)
다음 주에 진료가 잡혀 있다	해당 치료 장 + 워크북 「진료 기록지」
검사 결과지를 받았다	PART 1의 병리·검사·병기 장
돈·보험·회사가 걱정이다	PART 5 「돈 · 서류 · 제도」
마음이 무너질 것 같다	PART 4 「마음 돌보기」
가족으로서 무엇을 해야 할지 모르겠다	PART 4 「보호자에게」

각 장의 구성은 같습니다.

- **30초 요약** — 바쁠 때는 이 상자만 읽어도 됩니다.
- **본문** — 왜 그런지, 무엇을 확인하는지.
- **오늘 물어볼 질문** — 진료실에 가져갈 질문은 장마다 3개 이내로 골랐습니다.
- **기록칸** — 들은 내용을 그 자리에서 적습니다. 보호자가 적어도 좋습니다.
- **△ 응급 상자** — 기다리지 말고 연락해야 하는 신호입니다.

이 책의 표시:  확정된 정보 ·  검사·결정 대기 ·  아직 모름/확인 필요.
색이 아니라 기호로 구분했으니 흑백으로 인쇄해도 그대로 쓸 수 있습니다.

PART 1. 진단 첫 주 — 정확히 알기

1장. 먼저 구분하세요: 작은 신종양, 국소 신장암, 전이성

30초 요약

- 신장 종양은 건강검진·다른 검사 중 **우연히** 발견되는 경우가 많습니다.
- **4cm 이하 작은 신종양** 중 일부는 수술 후 **양성**으로 나옵니다. 그래서 크기·성장 속도·조직검사를 함께 보고 **감시·소작·부분절제** 중에서 고릅니다.
- 가장 흔한 조직형은 **투명세포 신세포암**이며, 조직형에 따라 전신치료가 달라집니다.
- 콩팥 하나로도 대부분 정상 생활이 가능합니다. 다만 **신장 기능 보존**이 치료 선택의 중요한 기준입니다.

상황	흔한 선택지
작은 신종양(약 4cm 이하)	적극적 감시 / 국소소작 / 부분신절제
국소 신장암(4cm 초과, 신장에 국한)	부분 또는 근치적 신절제
국소진행(정맥 침범 등)	근치적 신절제 ± 혈전 제거, 고위험이면 보조 면역치료
전이성	전신치료(면역 병용 등) ± 신절제·전이 절제·방사선

낭성 병변(Bosniak 분류) 한눈에

등급	의미(일반적)
I-II	대개 양성 낭종
III	추적 관찰

오늘 물어볼 질문

1. 제 종양의 크기와 위치는? 고형인가요, 낭성인가요?
2. 감시·소작·부분절제·전절제 중 무엇이 가능한가요?
3. 조직검사가 필요한가요?

2장. 기다리지 않는 신호

⚠ 응급 상자

- **소변에 핏덩이가 나오거나 소변이 막힘**, 심한 옆구리 통증
- 수술 후 **38°C 이상 발열**, 상처 고름, 배가 부풀고 아픔, 소변량 급감
- 갑작스러운 **홍통·숨참**, 한쪽 다리 부종(혈전)
- 면역치료 중: **심한 피로·어지럼·저혈압**(부신 위기), **심한 갈증·잦은 소변**(고혈당), **홍통·두근거림**(심근염), 심한 설사·혈변, 숨참
- **등 통증 + 다리 힘 빠짐·대소변 장애**(척수 압박)
- 먹는 표적치료 중 **혈압이 평소보다 크게 오르면서 심한 두통·흐린 시야·홍통**(고혈압 위기 — 기준 수치는 담당의 확인)
- 스스로를 해치고 싶은 생각 → ☎ 109, 119

본문 목록:

1. 혈뇨·소변 막힘은 출혈이나 핏덩이에 의한 막힘일 수 있습니다.
2. 수술 후 발열·복부 팽만·소변 감소는 감염·출혈·신장 기능 저하 신호입니다.
3. 암은 혈전 위험을 높입니다.
4. 면역치료 부작용 중 부신 위기·당뇨병·심근염은 드물지만 빠른 치료가 필요합니다.

5. 척추 전이에 의한 신경 압박은 시간이 중요합니다.
6. 혈관신생억제제는 혈압을 올릴 수 있어, 두통·흐린 시야를 동반한 급격한 혈압 상승은 바로 연락합니다.

밤·주말 연락처: _____ (병원 암 상담 전화·응급실)

3장. 진단 뒤 72시간

30초 요약: 오늘은 ① 영상 판독지 받기 ② 비뇨의학과(비뇨기종양) 예약 ③ 신장 기능(크레아티닌)·당뇨·고혈압 정리.

오늘 할 일 (3개)

- ☐ CT·MRI 판독지와 영상 CD
- ☐ 비뇨의학과(비뇨기종양 전문) 예약
- ☐ 신장 기능 수치, 당뇨·고혈압 여부, 복용 약 정리

이번 주 할 일

- ☐ 흉부 CT 등 병기 검사(PET/CT는 모든 환자에게 필요하지 않음)
- ☐ 신장 기능이 낮거나 조영제 알레르기가 있으면 검사 전 알리기
- ☐ 젊은 나이(대략 46세 이하)·양측·여러 개·가족력이면 **유전상담** 문의
- ☐ 산정특례: 대개 **병리 확진 후** 등록. 조직검사 없이 감시·수술 대기 중이면 등록 시점을 원무과에 확인

오늘 물어볼 질문

1. 영상에서 암일 가능성은 어느 정도로 보이나요?
2. 제 신장 기능은 수술 후 어떻게 될까요?
3. 유전상담이 필요한가요?

4장. 병리와 병기

30초 요약: 조직형(투명세포·유두상·협색소 등), 등급, 육종양 변화, 괴사, 절제면을 봅니다. 병리 결과가 **양성(암 아님)**으로 나오는 경우도 있습니다.

병기	쉬운 뜻
1기	7cm 이하, 신장에 국한
2기	7cm 초과, 신장에 국한
3기	신장 주위 지방·신정맥·대정맥 침범(T3a·T3b·T3c) 또는 림프절 전이
4기	신장을 싸는 막(제로타 근막)을 넘거나 같은 쪽 부신을 직접 침범(T4), 또는 원격전이

- 절제면에 암세포가 닿아 있다고 나와도 **곧바로 재수술을 뜻하지는 않습니다.** 추적 계획을 확인하세요.
- 흉부 CT의 작은 폐 결절-"불확정" 병변은 전이를 뜻하지 않을 수 있습니다. 추적 영상으로 확인합니다.
- 과거 결과지의 "유두상 1형/2형" 표기는 최신 분류에서 쓰지 않는 경향입니다 (확인 필요).

판독지 단어장

표현	쉬운 말
enhancing solid mass	조영제로 밝아지는 고형 종괴 — 암 가능성
cystic, Bosniak IIF	낭성, 추적 관찰 등급
macroscopic fat	눈에 보이는 지방 — 양성 혈관근지방종 가능성
renal vein thrombus	신정맥 종양 혈전

추적 영상 기록

날짜	검사	크기(cm)	판독 요약

PART 2. 치료 결정 — 2~3주차

5장. 작은 신종양: 감시·소작·부분절제

30초 요약: 크기·성장 속도·나이·신장 기능·동반질환·**불안 정도**를 함께 봅니다.
감시를 선택해도 불안은 자연스럽고, 불안이 너무 크면 그것도 치료 선택에 반영할 수 있는 정당한 요소입니다.

선택지	내용	생각할 점
적극적 감시	정기 영상으로 크기 변화 관찰	고령·동반질환·작은 종양에서 흔함
국소소작(고주파·냉동)	바늘로 종양을 태우거나 얼림	대개 3cm 안팎 이하, 시술 전·중 조직검사를 함께 하기도
부분신절제	종양만 떼고 신장 보존	신장 기능 보존에 유리, 위치에 따라 난이도 다름

- 감시는 보통 3~6개월마다 영상검사로 시작합니다. 치료로 바꾸는 흔한 기준 예: **1년에 약 5mm 이상 자람, 4cm를 넘음, 증상 발생**(담당 의료진 확인).

내 선택 비교표

기준	감시	소작	부분절제	전절제
신장 기능 보존	최상	높음	높음	낮음
확진(병리)	생검 시만	생검 동반 시	수술 후	수술 후
회복	없음	짧음	수주	수주
내 불안(0~10)				

기준	감시	소작	부분절제	전절제
내 선택 이유				

6장. 수술: 부분 vs 근치적 신절제

30초 요약: 가능하면 신장을 지키는 **부분신절제**를 우선 고려하고, 종양이 크거나 위치상 어려우면 **근치적 신절제**를 합니다. 복강경·로봇·개복은 종양에 맞춰 정합니다. 국내에서는 로봇 부분신절제술에 비급여 항목이 많아 본인 부담이 클 수 있습니다. 급여 범위가 넓어지는 중이니 예상 비용을 원무과에 확인하세요(확인 필요).

회복 일정(일반적 예시)

시기	할 일
입원 수일	걷기, 소변량 확인
2~4주	가벼운 활동, 무거운 물건 피하기
4~6주	대부분 일상 복귀(직업에 따라)
첫 영상	보통 수개월 안

신장 지키는 생활

- 소염진통제(NSAID) 장기 복용 피하기, 새 약은 신장 기능을 말하고 처방받기
- 혈압·혈당 관리, 충분한 수분(제한이 없을 때), 금연

7장. 수술 후 보조 면역치료

30초 요약: 재발 위험이 중간·고위험·고위험인 투명세포 신장암(전이 병소를 완전히 절제한 일부 포함)은 수술 후 **면역치료 약 1년**(대표 예: 펌브롤리주맵)이 범주로 권고되며, 재발 감소와 **생존 연장이 보고되었습니다**(국내 허가·급여 확인 필요). 보조 표적치료(먹는 약)는 일반적으로 우선 권고되지 않습니다.

- 보통 수술 후 회복을 거쳐 약 12주 이내에 시작하는 경우가 많으니(담당의 확인), 수술 후 회복과 함께 **종양내과 상담 일정**을 미리 잡으세요.
- 갑상선·부신 등 **내분비 부작용 일부는 회복되지 않아 호르몬약을 계속 먹어야 할 수 있습니다.**
- 면역치료 카드를 지갑에 넣고 응급실·다른 과 진료 때 보여 주세요.

"할까, 말까" 결정표

항목	내 경우
내 재발 위험(의료진 설명)	
기대 이득(숫자로 설명 요청)	
흔한 부작용 / 드문 중대 부작용 / 영구 가능 부작용	
방문 횟수(3주 또는 6주 간격)	
비용(산정특례 적용 시)	
내 결정과 이유	

8장. 전이성 신장암

30초 요약

- IMDC 위험군(양호/중간/불량)과 조직형으로 치료를 정합니다.
- 투명세포형 1차는 **면역 + 면역**(대표 예: 니볼루맙 + 이필리무맙) 또는 **면역 + 표적(먹는 혈관신생억제제)**(대표 예: 펌브롤리주맙 + 악시티닙) 병용 범주가 중심입니다(국내 허가·급여 확인 필요). 국내에서는 면역+면역 병용이 IMDC 중간·불량 위험군에서 건강보험 급여 대상입니다(2026.10 기준, 확인 필요). 양호 위험군이라면 급여되는 조합이 무엇인지 함께 물어보세요.
- 전이가 적고 천천히 자라는 일부는 **일정 기간 관찰 후 치료 시작**을 논의할 수 있습니다.
- 1차 이후에는 다른 표적치료, **HIF-2α 억제제** 등 후속 범주가 있습니다.
- 1차 이후에는 다른 표적치료(면역치료 뒤에는 카보잔티닙·엑시티닙 등을 흔히 씀), **HIF-2α 억제제** 등 후속 범주가 있습니다. HIF-2α 억제제는 국내에서 아직 쓰기 어려울 수 있어 사용 가능 여부와 임상시험을 함께 물어보세요(확인 필요).
- 선택된 경우 신절제·전이 절제·방사선(SBRT)을 함께 씁니다.

진행·전이로 진단받았다면

30초 요약

- 전이가 있어도 치료 선택지는 있습니다. 치료 목표가 **암을 조절하며 오래, 덜 아프게 사는 것**으로 바뀌는 경우가 많습니다.
- **완화(지지)의료는 마지막 단계의 돌봄이 아닙니다.** 진단 시점부터 항암치료와 함께 통증·피로·숨참·불안을 줄이는 치료입니다.
- 첫 진료에서 "제 치료 목표는 무엇인가요?"를 꼭 물어보세요.

치료 목표를 묻는 질문

1. 이 치료의 목표는 무엇인가요? (암 크기 줄이기 / 진행 늦추기 / 증상 줄이기)
2. 치료 효과는 언제, 어떤 검사로 확인하나요?
3. 이 치료를 받지 않거나 쉬면 어떤 일이 예상되나요?

완화의료 이용하기

- 대부분의 암 병원에 **완화의료팀(자문형)**이 있습니다. 통증, 숨참, 메스꺼움, 불면, 불안 조절을 담당 교수에게 요청하면 연결됩니다.
- 호스피스·완화의료는 입원형·가정형·자문형으로 나뉘며, 지정 기관과 이용 조건은 국립암센터 중앙호스피스센터 누리집이나 병원 사회사업팀에서 확인합니다.
- 완화의료를 받는다고 해서 항암치료를 포기하는 것이 아닙니다.

미리 생각해 둘 것(원할 때만)

- **사전연명의료의향서**: 19세 이상이면 건강할 때도 작성할 수 있습니다. 보건소·지정 등록기관에서 작성하며, 언제든지 변경·철회할 수 있습니다 (국립연명의료관리기관).
- 치료를 잠시 쉬거나 멈추는 선택도 존중되는 결정입니다. 결정은 한 번에 하지 않아도 됩니다.
- 내가 직접 말하기 어려워질 때 나 대신 의견을 전할 사람을 정해 가족에게 알려 둡니다.

2차 소견과 병원 선택

30초 요약

- 2차 소견은 담당 의사를 의심하는 일이 아니라 **큰 결정을 확인하는 일**입니다. 대부분의 의사는 자연스럽게 받아들입니다.
- 2차 소견 때문에 치료를 몇 주씩 미루지 않도록 **일정을 먼저 정하고** 움직입니다.
- 가장 중요한 준비물은 병리 슬라이드·블록과 영상 CD입니다.

2차 소견이 특히 도움이 되는 경우

- 병리 결과가 드문 조직형이거나, 병원마다 해석이 갈릴 수 있다고 들었을 때
- 수술과 비수술 치료 중 선택지가 둘 이상일 때
- 기능 보존 수술이나 드문 치료처럼 경험 많은 센터가 중요한 치료일 때
- 설명을 들었는데도 결정이 서지 않을 때

병원을 고를 때 물어볼 것

1. 이 병원에서 신장암 환자를 **다학제(여러 과가 함께 보는) 진료**로 상의하나요?
2. 제게 필요한 치료(수술·방사선·항암·임상시험 등)를 **한 병원**에서 받을 수 있나요?
아니면 연계 병원이 정해져 있나요?
3. 치료 중 밤이나 휴일에 문제가 생기면 **어디로 연락**하나요?
4. 첫 치료까지 대략 몇 주가 걸리나요?

집과의 거리도 중요한 기준입니다. 매일 가야 하는 방사선치료나 잦은 외래가 예정되어 있다면, 통원 부담과 응급 시 이동 시간을 함께 따져 보세요.

2차 소견 준비 체크리스트

- ☐ 진료의뢰서(상급종합병원은 필수)

- □ 병리보고서 + 슬라이드/블록 대여
- □ 영상 CD + 판독지
- □ 혈액검사 결과, 복용 약 목록
- □ 내가 가장 궁금한 질문 3개(워크북 「질문지」)

최신 치료와 임상시험

- 임상시험은 "마지막에 기대는 실험"만이 아닙니다. 진단 초기부터 **표준치료와 함께 고려할 수 있는 선택지**입니다.
- 임상시험에 참여해도 언제든 그만둘 수 있고, 위약(가짜약)만 단독으로 쓰는 암 임상시험은 드뭅니다. 위약이 포함되면 사전에 설명을 듣습니다.
- 연구 약값은 보통 연구 쪽이 부담하지만, 교통비·추가 방문 등 부대 비용은 확인이 필요합니다.

찾는 곳

- 담당 교수에게 "제가 참여할 수 있는 임상시험이 있나요?"라고 직접 묻기 — 가장 빠릅니다.
- 한국임상시험포털(KoNECT), 식품의약품안전처 의약품안전나라 임상시험 정보, ClinicalTrials.gov(영문)

물어볼 질문

1. 이 연구는 무엇을 비교하나요? 표준치료를 받지 못하게 되나요?
 2. 방문 횟수와 검사가 얼마나 늘어나나요?
 3. 중간에 그만두면 어떤 치료를 받게 되나요?
-

PART 3. 30일 실행 로드맵

Day 0-3 · 확인하기

- ☐ 판독지·CD ☐ 비뇨의학과 예약 ☐ 신장 기능·복용 약 정리 ☐ 연락처 저장

Day 4-7 · 검사받기

- ☐ 흉부 CT·혈액 ☐ 조직검사 여부 ☐ 유전상담(해당 시) ☐ 산정특례 시점 확인

Day 8-14 · 결정하기

- ☐ 감시/소작/부분/전절제 결정 ☐ 의사결정 워크시트 ☐ 필요 시 2차 소견

Day 15-21 · 준비하기

- ☐ 수술 전 검사 ☐ 간병·직장 일정 ☐ (전이성) 1차 치료 교육, 혈압계 준비

Day 22-30 · 시작하기

- ☐ 치료 또는 감시 시작 ☐ 증상·혈압 일지 ☐ 최종 병리 후 보조치료 상담 예약
-

PART 4. 치료 중·후의 몸과 마음

전신치료 중 자기 관리

30초 요약: 먹는 표적치료제는 **혈압 상승·설사·손발 피부 반응·피로·감상선 기능 저하**가 흔합니다. 집에서 혈압과 체중을 기록하세요.

증상	집에서	전화
혈압 상승	매일 기록	처방 기준 초과 지속, 두통·흐린 시야
설사	수분, 처방 지사제	하루 4~6회 이상, 탈수
손발 피부	보습, 두꺼운 양말	물집·통증으로 걷기 어려움
피로	짧은 낮잠, 걷기	일상생활 불가

- 혼자 산다면: 병원 사회사업팀(의료사회복지사),
지자체 병원 동행 서비스·돌봄 서비스를 문의하세요
(지역별 확인).

추적

- 수술 후 첫 영상은 보통 수개월 안에 찍습니다. 국내 자료에서는 대개 2년까지 3~4개월마다, 그 뒤 6개월~1년마다, 5년이 지나면 1~2년마다 검사하는 일정을

예로 듭니다(병기에 따라 다름). 드물게 아주 늦게 재발하기도 해 5년 뒤에도 추적이 이어질 수 있습니다.

- 신장 기능(크레아티닌)과 혈압을 함께 추적합니다.

치료 중 흔한 증상, 집에서 할 일과 연락 기준

아래는 여러 암 치료에서 공통으로 흔한 증상입니다. **치료 병원의 안내가 항상 우선**이며, "연락" 칸에 해당하면 다음 예약까지 기다리지 마세요.

증상	집에서 할 수 있는 것	연락할 때
메스꺼움·구토	처방받은 구토 예방약을 시간 맞춰 (증상이 생긴 뒤가 아니라 미리). 조금씩 자주, 차갑고 냄새가 약한 음식, 생강차·크래커	하루 3회 이상 구토, 물도 못 마심, 24시간 소변이 거의 없음
피로	짧은 낮잠(30분 이내), 가벼운 걷기, 우선순위 정해 에너지 아끼기, 도움 요청	숨참·어지럼·심한 창백(빈혈 가능), 일상생활이 불가능
입안 혈음	부드러운 칫솔, 무알코올 가글(소금·베이킹소다 물), 자극적·뜨거운 음식 피하기	통증으로 먹거나 마시지 못함, 흰 반점·출혈, 발열 동반
변비	수분, 걷기, 처방 변비약. 진통제(마약성) 복용 중이면 변비약을 미리 함께	3일 이상 변이 없고 복통·구토, 배가 부풀
설사	수분·전해질(이온음료 희석, 미음), 기름진 음식·유제품·카페인 줄이기, 처방 지사제	하루 4~6회 이상, 밤에도 계속, 혈변, 어지럼·소변 감소, 면역치료 중 설사
불면	일정한 기상 시간, 낮잠 제한, 잠자리에서 휴대폰 멀리, 스테로이드는 아침 복용(지시대로)	2주 이상 계속, 불안·우울 동반

증상	집에서 할 수 있는 것	연락할 때
탈모	순한 샴푸, 짧은 머리, 모자·두건·가발, 두피 자외선 차단	— (대개 치료 후 다시 자람)
피부 발진·건조	순한 보습제 하루 2회 이상, 미지근한 물, 자외선 차단	물집·벗겨짐, 넓게 번짐, 점막 (입·눈) 침범
손발 저림	찬 것 피하기(일부 약), 따뜻한 양말·장갑, 낙상 주의	단추·젓가락·검기가 어려워짐 — 다음 투여 전에 꼭 알리기
식욕 저하·체중 감소	먹을 수 있을 때 먹기, 고단백 간식, 영양 보충 음료	한 달 5% 이상 체중 감소, 평소의 절반 이하로 1주 이상

열이 나면: 항암 중 38°C 이상(병원 기준에 따라 37.8°C 이상 1시간 지속 등)은 **해열제를 먹기 전에 먼저 연락**하는 것이 원칙입니다. 열을 내리면 감염 신호를 놓칠 수 있습니다.

마음 돌보기

30초 요약

- 진단 후 불안, 잠 못 들, 멍함, 화, 눈물은 **흔하고 자연스러운 반응**입니다. 약해서가 아닙니다.
- 2주 넘게 일상이 무너지거나, 스스로를 해치고 싶은 생각이 들면 **혼자 견디지 말고** 바로 도움을 요청하세요.
- 자살·정신건강 위기 상담 ☎ **109**(24시간), 응급 ☎ **119**
- 지금 마음의 고통은 0~10 중 ____ 점. 4점 이상이면 다음 진료에서 그대로 말하세요.

내 마음 온도계(고통 선별)

지난 1주일 동안 내 마음의 고통은 몇 점이었나요? (0 = 전혀 없음, 10 = 극심함)

날짜 점수(0~10) 가장 힘든 것(☐ 걱정 ☐ 잠 ☐ 통증 ☐ 돈 ☐ 가족 ☐ 일 ☐ 기타)

- **4점 이상**이 계속되면 다음 진료 때 점수를 그대로 말하세요. 대부분의 암 병원에는 정신건강의학과·임상심리·사회사업팀 연결 경로가 있습니다.
- 불면이 1~2주 이상 계속되면 수면 치료를 받을 수 있습니다. 잠은 치료를 견디는 체력입니다.
- 병원 밖 도움: 전국 지역암센터의 **암생존자통합지지센터**(☎ 1577-9740)에서 상담·심리지지·자기관리 프로그램을 운영합니다. 암 정보가 궁금하면 국가암지식정보센터 상담(☎ 1577-8899, 평일 9~18시)을 이용할 수 있습니다.

불안이 물려올 때 5분 방법

1. **숨:** 4초 들이쉬고, 6초 내쉬기를 5번.
2. **이름 붙이기:** "지금 나는 ○○ 결과가 걱정된다"라고 소리 내거나 적기.

3. **내 몫 나누기**: 지금 내가 할 수 있는 일 1개(전화 1통, 서류 1장)와 의료진 몫을 나눠 적기.
4. **정보 시간 정하기**: 인터넷 검색은 하루 30분, 정해 둔 시간에만. 밤 검색은 불안을 키웁니다.

"내 탓일까?"라는 생각

암은 한 가지 원인으로 생기지 않습니다. 생활습관, 감염, 유전, 나이, 그리고 설명되지 않는 우연이 겹칩니다. **원인 찾기보다 지금부터의 계획**에 에너지를 쓰는 편이 나를 돕습니다. 가족이나 주변 사람이 원인을 따져 묻는다면 "지금은 치료 계획에 집중하고 싶어"라고 말해도 됩니다.

희망과 현실을 함께 들고 가기

통계(생존율)는 많은 사람의 평균이지 나 한 사람의 예언이 아닙니다. 궁금하다면 담당 의사에게 "제 병기와 상태에서 치료 목표가 무엇인가요?"라고 물어보세요. 듣고 싶지 않은 정보는 "지금은 듣지 않겠다"고 말할 권리도 있습니다.

보호자에게

보호자가 첫 30일에 할 수 있는 가장 좋은 일

- **기록 담당**: 진료실에서 답을 적습니다. 환자는 듣는 데 집중할 수 있습니다.
- **일정 담당**: 검사·진료·서류 일정을 한 곳(달력·앱)에 모읍니다.
- **연락 창구**: 친척·지인에게 소식을 전하는 사람을 한 명으로 정하면 환자가 같은 이야기를 반복하지 않아도 됩니다.
- **결정은 환자가**: 의견은 말하되, 치료 결정의 주인은 환자입니다.

피하면 좋은 말과 바꿔 쓸 말

피하면 좋은 말	바꿔 쓸 말
"긍정적으로 생각해야 나아"	"힘든 마음 그대로 말해도 돼"
"왜 검진을 안 받았어"	"지금부터 같이 챙기자"
"○○ 먹으면 낫는데"	"새로 먹고 싶은 게 있으면 의사 선생님께 같이 물어보자"
"너보다 더 힘든 사람도 있어"	"네가 힘든 건 힘든 거야"

아이에게 알릴 때

- 아이의 나이에 맞게, **짧고 사실대로**: "(엄마·아빠·할머니 등 아이가 부르는 호칭)가 몸에 아픈 곳이 생겨서 병원에서 치료를 받을 거야."
- 아이가 자주 하는 걱정 세 가지에 먼저 답합니다: **네 탓이 아니야 / 윗은 병이 아니야 / 누가 너를 돌봐줄지 정해져 있어.**
- 학교 담임에게 알릴지, 누가 알릴지 미리 정합니다.

보호자의 휴가 제도

일하는 보호자는 **가족돌봄휴직**(연간 최대 90일)과 그 안에서 하루 단위로 쓰는 **가족돌봄휴가**(연간 최대 10일)를 회사에 신청할 수 있습니다(남녀고용평등법, 2026.10 기준·고용노동부 확인). 진료 동행이 잦은 첫 30일에 특히 유용합니다.

보호자 자신을 위해

보호자의 소진은 흔합니다. 하루 30분은 나를 위한 시간을 지키세요. 병원 사회사업팀과 환우·보호자 모임은 보호자도 이용할 수 있습니다.

직장과 일상

- **언제·누구에게·얼마나** 말할지는 내가 정합니다. 직속 상사와 인사 담당자에게 "치료 일정 때문에 근무 조정이 필요하다" 정도만 알려도 충분한 경우가 많습니다.
- 치료 일정이 나오면 **근무 조정안**(단축근무, 재택, 연차·병가 조합)을 내가 먼저 제안하면 협의가 쉬워집니다.
- 피로는 치료 중 가장 흔한 증상입니다. 치료 직후 며칠은 일을 줄이는 계획을 미리 세웁니다.
- 자영업자라면 매출보다 **현금 흐름 3개월**을 먼저 계산하고, 사회사업팀에 지원제도를 문의합니다.
- 복귀는 한 번에 100%가 아니라 단계적으로. 복귀 시점은 담당 의사와 상의합니다.
- 암생존자통합지지센터(☎ 1577-9740)에는 직장·학교 복귀를 돕는 프로그램이 있습니다(지역별 운영 확인).

먹는 것과 움직이는 것

식사 원칙

- 치료 중 목표는 "특별한 음식"이 아니라 **체중과 근육 유지**입니다. 고른 식사와 충분한 단백질(생선·달걀·두부·살코기·유제품)을 챙깁니다.
- 암 치료에 특별히 좋은 음식이나 꼭 피해야 할 "나쁜 음식"이 따로 정해져 있지는 않습니다. "좋은 음식"만 먹거나 여러 음식을 가리면 오히려 영양이 치우치고 체력이 떨어져 치료를 버티기 어려워집니다.
- 입안이 험했을 때는 잡곡밥보다 부드러운 흰쌀밥이 나올 수 있고, 체중이 줄고 있다면 기름을 지나치게 제한할 필요도 없습니다. 유기농 식품이 치료에 특별히 도움이 된다는 근거는 뚜렷하지 않습니다.

- 체중이 한 달에 5% 이상 줄거나 먹는 양이 평소의 절반 이하로 1주 이상 이어지면 영양 상담을 요청합니다.
- 항암치료 중 면역이 떨어질 때는 날음식·덜 익힌 고기·살균 안 된 유제품을 피하라는 안내를 받을 수 있습니다. 병원 안내를 따르세요.
- **건강기능식품·한약·즙·고용량 비타민**은 항암제나 수술·방사선과 상호작용하거나 간·신장에 부담을 줄 수 있습니다. 시작 전에 꼭 의료진과 약사에게 보여 주세요.

움직이기

- 걷기처럼 가벼운 활동은 피로와 기분을 개선하는 근거가 있습니다. 컨디션에 맞춰 하루 10분부터 시작합니다.
 - 일반적인 건강 목표는 주 150분 중간 강도 활동이지만, 치료 중에는 **할 수 있는 만큼**이 기준입니다.
 - 발열, 심한 빈혈·어지럼, 뼈 전이 통증, 수술 직후에는 운동 강도를 의료진과 상의합니다.
 - 담배는 상처 회복과 치료 효과, 다른 암 위험에 모두 영향을 줍니다. 금연 클리닉(보건소)과 금연상담전화 ☎ **1544-9030**을 이용하세요.
-

PART 5. 돈 · 서류 · 제도

한국에서 꼭 챙길 제도와 서류

30초 요약

- 1. **산정특례 등록**: 암 확진 후 **30일 이내**에 신청하면 확진일부터 건강보험 본인부담이 크게 줄어듭니다(급여 항목 기준 5%). 진단받은 병원 원무과에 "산정특례 신청"을 오늘 물어보세요.
- 2. **서류는 처음부터 두 부씩**: 병리보고서, 영상 판독지, 진단서는 보험·회사·2차 소견에 반복해서 쓰입니다.
- 3. **제도는 바뀔니다**: 금액·기준은 2026년 10월 기준이며, 공단(1577-1000)·원무과에서 다시 확인합니다.

1. 산정특례(중증질환 본인부담 경감)

항목	내용(2026.10 기준, 확인 필요)
대상	암으로 확진된 환자(신장암 포함). 상피내암(0기)·경계성 종양 등은 대상·비율이 다를 수 있어 원무과 확인
혜택	건강보험 급여 진료비의 본인부담 약 5%(입원·외래). 비급여·선별급여는 해당하지 않거나 비율이 다름
기간	적용 시작일(확진일 또는 신청일)부터 5년. 5년 뒤 남아 있는 암·재발·전이가 있으면 재등록 심사
신청 시한	확진일로부터 30일 이내 신청하면 확진일부터 적용. 그 뒤에 신청하면 신청일부터 적용
방법	진단한 의사가 산정특례 등록 신청서를 작성 → 대부분 병원 원무과가 공단에 전송. 직접 제출도 가능

확인할 것

- ☐ 병원이 대신 접수했는지, 등록 결과(문자·공단 앱)를 받았는지
- ☐ 다른 병원으로 옮겨도 산정특례는 유지됩니다. 새 병원 원무과에 등록 사실만 알리면 됩니다.
- ☐ 확진 전 검사비는 적용 시점에 따라 경감되지 않을 수 있습니다.

2. 의료비 부담을 덜어주는 제도

제도	핵심	문의
본인부담상한제	1년간 낸 건강보험 본인부담금이 소득 구간별 상한을 넘으면 남은 금액을 돌려받음(비급여 제외)	국민건강보험공단 1577-1000
재난적 의료비 지원	소득·재산 기준을 충족하고 의료비 부담이 큰 경우 일부 지원(비급여 일부 포함)	공단 지사·병원 사회사업팀
국가 암환자 의료비 지원	의료급여 수급자·차상위 등 해당자 대상 지원	주소지 보건소
병원 사회사업팀 (의료사회복지사)	후원 연계, 간병·교통·숙소 정보, 제도 신청 도움	진료 병원 사회사업팀

대상 기준과 금액은 해마다 바뀝니다. "내가 해당되는지"는 병원 사회사업팀에 한 번에 물어보는 것이 가장 빠릅니다.

3. 보험 청구 서류 체크리스트

민간 암보험(진단비)

- ☐ 진단서(질병분류코드 포함) — 보험사 양식이 있는지 먼저 확인
- ☐ 조직병리검사 결과지(병리보고서) — 대부분의 약관이 병리 확정을 요구합니다

- □ 약관에서 "**유사암·소액암**"(갑상선암, 제자리암/상피내암, 경계성 종양, 기타 피부암 등) 분류를 확인 — 진단비가 다를 수 있습니다
- □ 청구 기한(보험금 청구권 소멸시효는 3년)

실손의료보험

- □ 진료비 영수증 + 진료비 세부산정내역서(비급여 항목 확인용)
- □ 일정 금액 이상은 진단서·입퇴원확인서 추가
- □ 가입 시기에 따라 보장 범위(비급여 주사·도수 등)가 다릅니다

보험 상담에서 "진단서는 몇 통이 필요한가요?"를 먼저 물어보고, 병원에서는 한 번에 필요한 부수만큼 발급받으면 비용과 시간을 아낄 수 있습니다.

4. 회사·학교에 낼 서류

- □ 진단서 또는 소견서(치료 예정 기간 포함 여부 확인)
- □ 회사 취업규칙의 **병가·질병휴직** 조항 확인 — 법정 의무 병가는 없고 회사 규정에 따름(공무원·교원은 별도 규정)
- □ 상병수당: 일부 지역 시범사업 중 — 거주 지역·자격을 공단에 확인
- □ 개인 의료정보는 **필요한 만큼만** 알립니다. 병명 공개 범위는 내가 정합니다 (PART 4 「직장과 일상」 참고).

5. 진료 서류 모아두기(2차 소견·전원 대비)

서류	어디서	메모
병리보고서(조직검사 결과지)	진단 병원 의무기록팀	바이오마커 결과 포함 여부
병리 슬라이드·파라핀 블록 대여	진단 병원 병리과	다른 병원 재판독·추가검사에 필요. 반납 기한 확인

서류	어디서	메모
영상 CD + 판독지	진단 병원 영상의학과· 의무기록팀	CT·MRI·PET 모두
혈액검사 결과	의무기록팀	최근 것
진료의뢰서(소견서)	담당 의사	상급종합병원 외래는 의뢰서가 있어야 건강보험 적용

신장암 참고: 질병코드는 C64입니다. 조직검사 없이 감시하는 동안에는 병리
확진이 없어 보험 진단비 청구가 어려울 수 있습니다. 약관의 진단 확정
조건을 확인하세요.

PART 6. 진료실 도구

진료실 질문 모음 — 한 번에 3개씩

진단 직후에는 1~3번, 치료를 정할 때는 4~7번, 치료 시작 전후에는 8~10번 중 **3개만** 골라 가세요. 보호자가 답을 적으면 충분합니다. 1. 종양의 크기·위치, 고형/낭성은요? 2. 감시·소작·부분절제·전절제 중 무엇이 가능한가요? 3. 조직검사가 필요한가요? 4. 수술 후 신장 기능은 어떻게 될까요? 5. 조직형과 등급은요? 6. 보조 면역치료 대상인가요? 기대 이득은요? 7. 전이성이라면 IMDC 위험군과 1차 치료는요? 8. 유전상담이 필요한가요? 9. 바로 연락해야 할 증상은요? 10. 임상시험이 있나요?

내 신장암 한 장 요약

항목	내 기록
크기·위치	_ cm , _
고형/낭성(Bosniak)	_____
조직형·등급	_____
병기	_____
신장 기능	수술 전 _ / 후 _
첫 치료	감시 / 소작 / 부분절제 / 전절제 / 전신치료
보조치료	해당 없음 / 상담 / 시작
IMDC(전이성)	양호 / 중간 / 불량

오늘 꼭 물을 3가지: ① 감시가 가능한가요? ② 신장을 지킬 수 있나요? ③ 보조치료가 필요한가요?

같은 진단, 다른 30일 (가상 사례)

감수단 환자 페르소나를 바탕으로 재구성한 가상의 이야기입니다.

57세 태수 씨 — 우연 발견 3cm 종양 "신장 하나로 살 수 있나"가 첫 질문이었다. 결정표에 감시·소작·부분절제를 나란히 적고, 불안 점수 8점을 솔직하게 썼다. 담당의와 상의해 부분절제를 택했다. "불안도 선택의 이유가 될 수 있다는 말이 위로가 됐어요."

64세 정희 씨 — 고위험 수술 후 보조 면역치료 권유 기대 이득을 숫자로 설명해 달라고 했다. 부작용 중 영구적일 수 있는 것도 들었다. 결정까지 일주일을 썼다. "제 결정이라는 확신이 있으니 부작용이 와도 덜 흔들려요."

69세 만석 씨 — 전이성, 혼자 사는 남성 혈압계와 약 달력을 받아 냉장고에 붙였다. 사회사업팀이 병원 동행 서비스를 연결해 주었다. "혼자라서 못 할 줄 알았는데, 도와줄 곳이 생각보다 많았습니다."

용어사전

용어	쉬운 뜻
작은 신종양	약 4cm 이하 신장 종양
Bosniak 분류	신장 낭종의 악성 가능성 등급
투명세포 신세포암	가장 흔한 신장암
부분신절제 / 근치적 신절제	종양만 / 신장 전체 제거
국소소작	고주파·냉동으로 종양을 파괴

용어	쉬운 뜻
적극적 감시	정기 영상으로 관찰
IMDC 위험군	전이성 신장암 위험 분류
보조 면역치료	수술 후 재발을 줄이는 면역치료
HIF-2 α 억제제	신장암 성장 신호를 막는 먹는 약
VHL 증후군	신장암 위험을 높이는 유전 질환

자주 묻는 질문 12

Q1. 조직검사 없이 수술하는 경우가 많은 이유는요? 영상으로 암 가능성이 높고 수술이 치료이자 진단이 되는 경우가 많기 때문입니다. 감시나 소작을 고려하거나 결과가 치료를 바꿀 때는 조직검사를 합니다. 요즘 영상을 보며 하는 바늘 조직검사는 출혈이 4% 미만, 바늘 길로 암이 퍼지는 일은 매우 드물고(0.01% 미만), 진단 정확도는 약 90~95%로 보고됩니다.

Q2. 신장 하나로 살면 투석하게 되나요? 대부분은 그렇지 않습니다. 다만 당뇨·고혈압·원래 신장 기능이 나쁘면 위험이 높아질 수 있어 부분절제를 우선 고려합니다.

Q3. 감시하다가 놓치면 어떡하죠? 작은 신종양은 대개 천천히 자라 정기 영상으로 변화를 확인할 수 있습니다. 빠르게 커지면 그때 치료합니다.

Q4. 수술 후 짠 음식·단백질을 제한해야 하나요? 신장 기능에 따라 다릅니다. 일반적으로 과도한 짠 음식은 피하고, 신장 기능이 떨어졌다면 영양 상담을 받으세요.

Q5. 진통제는 아무거나 먹어도 되나요? 소염진통제(NSAID)는 신장에 부담이 될 수 있어 장기 복용을 피하고, 새 약은 신장 기능을 말하고 처방받으세요.

Q6. 보조 면역치료를 받지 않으면 손해인가요? 고위험군에서 재발을 줄이고 생존을 늘린다는 결과가 있지만, 부작용도 있습니다. 내 위험도에서의 기대 이득을 숫자로

듣고 결정하세요.

Q7. 전이가 있으면 신장을 떼나요? 일부 선택된 환자에서 신절제를 함께 하지만, 많은 경우 전신치료를 먼저 합니다. 다학제 상의가 필요합니다.

Q8. 먹는 표적치료제를 먹으면 혈압이 오르나요? 흔한 부작용입니다. 집에서 매일 혈압을 재고 기준을 넘으면 알려세요. 혈압약으로 조절합니다.

Q9. 신장암은 유전되나요? 대부분은 아니지만, 젊은 나이·양측·여러 개·가족력이 있으면 유전상담(VHL 등)을 받습니다.

Q10. 소변에 피가 한 번 나왔다 멈췄어요. 멈췄더라도 알려세요. 핏덩이가 생기거나 소변이 막히면 바로 연락합니다.

Q11. 운동은 언제부터 가능한가요? 수술 후 걷기는 바로 시작하고, 무거운 물건·격한 운동은 4~6주 뒤 상의합니다.

Q12. 혼자 사는데 치료를 감당할 수 있을까요? 병원 사회사업팀과 지자체 돌봄·동행 서비스를 연결할 수 있습니다. 비상 연락 카드를 만들어 이웃이나 가족에게도 알려 두세요.

진료실 대화법: 15분 진료를 30분처럼

30초 요약: 질문은 3개로 줄여 가져가고, 보호자가 적고, 마지막에 "제가 이해한 것이 맞는지 말해 볼게요"로 확인합니다.

진료 전달

- ☐ 질문 3개를 우선순위대로 적기(워크북 W2)
- ☐ 지난 진료 이후 바뀐 증상·약을 한 줄씩
- ☐ 검사 결과지·영상 CD·복용 약 목록 챙기기

진료실에서

- 1. 첫 문장으로 가장 중요한 것부터: "오늘 가장 궁금한 건 첫 치료가 무엇이고 언제 시작하는지예요."
- 2. 어려운 말이 나오면: "그 말을 쉽게 다시 설명해 주시겠어요?" "종이에 적어 주실 수 있나요?"
- 3. 선택지가 나오면: "선택지마다 장점과 단점, 그리고 선생님이라면 무엇을 고르실지 여쭙봐도 될까요?"
- 4. 끝나기 전: "제가 이해한 대로 말해 볼게요. ○○하고, 다음은 ○월 ○일 ○○ 검사죠?"
- 5. 연락처: "집에서 문제가 생기면 누구에게 연락하나요?"

녹음하고 싶다면

진료 내용을 기억하기 위해 녹음하고 싶을 때는 먼저 의료진에게 양해를 구하세요. 허락이 어려우면 보호자 기록으로 대신합니다.

다학제 진료

여러 과(수술·종양내과·방사선종양학과·영상의학과·병리과 등)가 한자리에서 치료를 상의하는 진료입니다. 치료 선택지가 여럿이거나 순서가 중요한 경우 "다학제 진료를 받을 수 있나요?"라고 물어보세요.

검사 준비 카드

검사	준비	알려야 할 것	소요(대략)
CT(조영)	몇 시간 금식(병원 지시), 물 충분히(제한 없을 때)	조영제 알레르기, 신장 기능 저하, 당뇨약 (메트포르민), 임신 가능성	촬영은 10~20분

검사	준비	알려야 할 것	소요(대략)
MRI	금속 제거, 일부는 금식	심박동기·인공와우·몸속 금속, 폐소공포증(진정 상담), 신장 기능	30~60분
PET/CT	(FDG PET) 4~6시간 금식, 전날 격한 운동 피하기 · 다른 종류의 PET은 병원 안내	당뇨(혈당 조절법 미리 확인), 임신·수유	주사 후 대기 포함 2~3시간
조직검사 (바늘)	금식 여부 확인	혈액을 묽게 하는 약(중단 여부는 의료진 지시), 알레르기	시술 후 관찰 수시간
내시경	금식, 대장은 장 정결제	혈액을 묽게 하는 약, 당뇨약	진정 시 보호자 동행·당일 운전 금지
뼈스캔	주사 후 물 많이 마시기	임신·수유	주사 후 2~4시간 대기

검사 결과는 "검사를 한 날"이 아니라 **"결과 설명을 듣는 날"**을 미리 예약해 두면 기다리는 불안이 줄어듭니다.

워크북

이 장은 오려 쓰거나 복사해 쓰도록 만들었습니다. 진료실에는 이 페이지만 들고 가도 됩니다.

W1. 비상 연락처 카드 (휴대폰 사진으로도 저장)

항목	기록
담당 교수 / 진료과	
평일 진료실·외래 간호사실 ☎	
야간·휴일 연락처 ☎	
가까운 응급실(치료 병원 우선)	
항암·방사선 치료실 ☎	
보호자 1 / 보호자 2 ☎	
국가암지식정보센터 암정보 상담(평일 9~18시)	☎ 1577-8899
암생존자통합지지센터(지역암센터)	☎ 1577-9740
응급 119 · 정신건강 위기 109	

W2. 진료 기록지 (진료마다 1장)

항목	기록
날짜 / 진료과 / 의사	
오늘 들은 진단·병기	✓ / ⏳ / ?
오늘 결정된 것	
다음 검사·날짜	
다음 진료 날짜	
새로 받은 약	
꼭 지켜야 할 주의사항	

항목	기록
다음에 물어볼 것	

W3. 7일 증상 일지

날 짜	체온 (최고)	통증 0~10	식사(평소의 %)	배변· 배뇨	잠	기분 0~10	메모·연락 여부

W4. 복용 약·보충제 목록 (모든 진료에 지참)

이름	용량·횟수	왜 먹나	처방한 곳	의료진에 알림
				☐
				☐
				☐
				☐

혈액을 묽게 하는 약(항응고제·항혈소판제), 당뇨약, 한약·건강기능식품은
수술·시술·항암 전에 특히 중요합니다.

W5. 30일 체크 달력

주	날짜	한 일(✅) / 남은 일(🕒)
1주(Day 0-7)		

주	날짜	한 일(✔) / 남은 일(⌚)
2주(Day 8-14)		
3주(Day 15-21)		
4주(Day 22-30)		

근거와 한계

- **참고 지침:** NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) — Kidney Cancer, Version 1.2027. NCCN의 표·알고리즘·문장을 옮기지 않고, 환자 언어로 새로 썼습니다.
- **국내 자료:** 국가암지식정보센터(www.cancer.go.kr) 신장암 정보, 대한비뇨의학회·대한비뇨기종양학회 자료, 국민건강보험공단 산정특례 안내
- **국가암지식정보센터 자료의 이용 방식:** 이 책은 국가암지식정보센터(구 국가암정보센터)의 글·표·그림을 옮기거나 고쳐 실지 않았습니다. 같은 사실을 대조·확인하는 데 참고했고, 문장은 ApuDa가 새로 썼습니다(센터 저작권 안내의 이용조건: 비영리·저작권 표시·내용 변경 금지·영리 이용 시 사전 협의를 따릅니다).
- **참고문헌:** 보건복지부·국립암센터 국가암지식정보센터, 신장암 정보(확인일 2026.10.04). 사실 확인용 참고문헌이며, 국가암지식정보센터의 저작물을 수록하지 않았습니다. 독자 안내: 공식 암 정보와 무료 상담은 www.cancer.go.kr, ☎ 1577-8899.
- **의학정보 확인일:** 2026.10.04. 약의 국내 허가·급여, 면역치료·표적치료 적용 기준, 제도 금액은 바뀔 수 있습니다.
- **감수:** ApuDa 「첫 30일」 감수단(전문의 30인·환자 36인·편집자문 3인 역할 기반 **AI 사전 검토단**)의 1·2차 검토를 반영했습니다. 이 검토는 실제 면허 의료진의 최종 감수를 대신하지 않습니다. 출판본에는 실제 감수자 명단이 별도 표기됩니다.

- 이 책은 NCCN이 검토·승인한 자료가 아니며, NCCN과 무관한 ApuDa의 독자적 환자교육 저작물입니다.
 - 이 자료는 일반적인 환자교육용이며 개인의 진단·처방·치료 결정을 대신하지 않습니다.
-

ApuDa | 아프지만, 다행이다. · <https://apuda.app/>